

Status du nouveau-né

Introduction

Le status du NN se déroule selon l'envie et les besoins de l'examineur. Toutefois, à visée générale (comme lors d'un 1er entretien avec le NN), une approche systématique et plus large sera adoptée. Cette dernière consistera à aborder tous les grands systèmes du corps humain, dans une optique orientée vers le NN et les pathologies les plus couramment retrouvées à cet âge.

Concernant la préparation au status, il sera important de:

- Confortablement installer le NN...
- ... et de confortablement s'installer soi-même
- Vérifier la T° de la pièce (NN perdent vite de la chaleur!)

Anamnèse

La systématique adoptée dans l'anamnèse suivra les étapes suivantes: grossesse, accouchement, néonatalogie et RAD.

- 1) **Grossesse:** déroulement général, suivi, parité-gestité, terme/RCIU/macrosomie, fratrie, US gestationnels, maladies durant la grossesse (diabète, infection, fièvre, ... + ttt entrepris), drogues, OH, groupe sanguin, métier, infections virales (HCV, HBV, HIV, CMV), social, ATCD familiaux de maladies génétiques
- 2) **Accouchement:** terme (37-42 SA), voie d'accouchement, accouchement provoqué/instrumenté, Apgar, CTG, sepsis néonatal (risques : strepto B+, prématurité, infection chez la mère, rupture des membranes >18h), analgésie péri-partum, anesthésie si césarienne
- 3) **Néonatalogie:** mesure taille et poids NN tout frais (taille tête-pieds, PC et poids), CAVE perte max 10% poids les 2 premiers jours après naissance (repris en environ 2 semaines), status NN (réalisé 48-72h après), ictère, signes vitaux (surtout la T° !), 1ères urines (retard >24h) et selles (retard >48h), test de Güttri (48h), sérologie spécifique selon les cas, test d'audition (N : 48h ; 1^{er} jour de vie présence encore liquide dans oreille interne), vitamine K (4h, 4j, 4sem → très peu dans le lait maternel et nécessité flore mature), vitamine D (10j de vie jusqu'à 3 ans, 1x par jour), reste de cordon tombe 1-2sem de vie
- 4) **Sortie hôpital:** rdv avec le pédiatre à 1 mois de vie, vaccins (1ers au 2^e mois), CAVE mort subite du NN (risques : dormir sur le ventre, fumée, T° inadéquates (18-20°), absence d'allaitement), conseils jaunisse, plagiocéphalie

Approche systématique (status)

Comme pour tout examen physique, l'inspection sera le premier point abordé. Viendra, par la suite, l'approche par systèmes qui permettra de mettre en évidence une quelconque pathologie.

Inspection

Celle-ci comprendra les éléments suivants:

- **Aspect général** du NN (mouvements, pleurs, vocalisations, etc.)
- **Couleur** (rouge, bleu, jaune) et si elle concerne tout ou une partie du corps
- **Symétrie des membres** (séquence de Potter, par exemple)
- **Dysmorphies** (évocateur de T21, par exemple)

L'inspection sera également l'occasion de prendre les **mensurations** du NN:

- Taille (tête aux pieds)
- Poids (N=perte <10% repris après la naissance)
- PC (occiput à bandeau frontal)

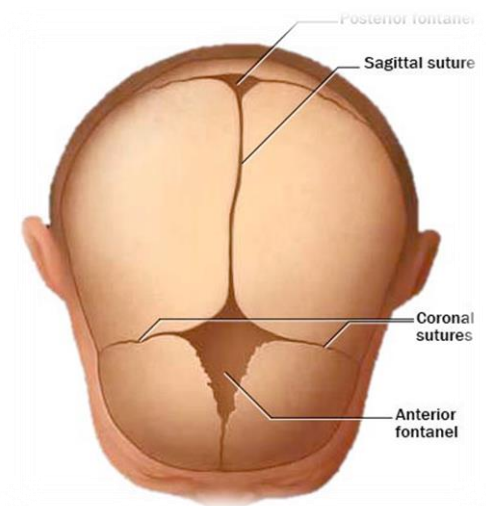
Examen physique

Afin de ne pas se perdre dans notre travail, une bonne façon de faire est de pratiquer le status du NN en allant de la **tête aux pieds**. Ceci sera fait en abordant les systèmes suivants (ordre variable): cardiorespiratoire, digestif, génital, nerveux, locomoteur et visuel.

TÊTE

Fontanelles

- Présence (fontanelle postérieure peut déjà être fermée)
- Taille (environ 2 cm de diamètre)
- Tension (palpable et/ou visible au toucher)



Sutures crâniennes

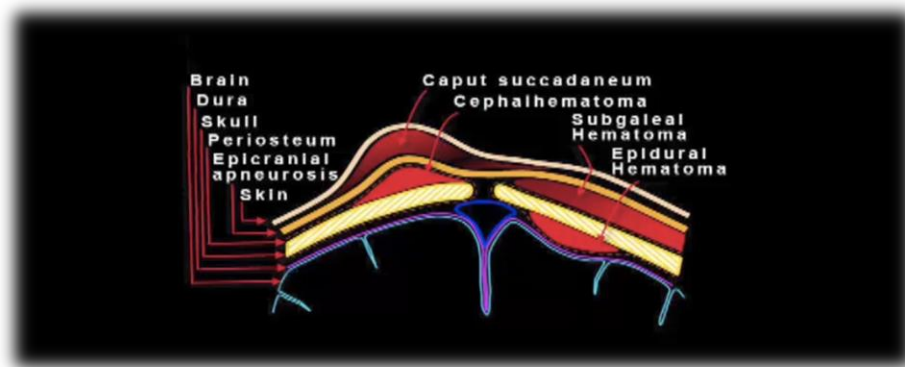
Elles peuvent être légèrement chevauchantes voire pas encore fusionnées. L'absence de suture (visible aux stades précoces de la vie) permet de mobiliser les différents os du crâne.

Chaque suture crânienne devra être palpée:

- Coronale
- Sagittale
- Lambdoïde

Voûte crânienne

On vérifiera ici l'aspect général du crâne afin de détecter la présence de déformations. De façon générale, les déformations sont dues à des **hématomes** causés au moment de l'accouchement (instrumentation, par exemple). Ces derniers peuvent se situer à plusieurs niveaux (cf. image ci-dessous).



Yeux

- Strabisme
- Oculomotricité
- Réflexes pupillaires (fait partie du status neuro)



Cavité buccale

- Langue: couleur, apparence, cyanose centrale?
- Dents: présence de bourgeons ou non
- Palais: fente palatine? (FP=acide folique péri-gestationnel)
- Autres?



Visage

Apparence générale du visage en regardant: nez, bouche, menton, joues, etc. Le but sera d'inspecter la présence d'**asymétries** ou de **dysmorphies**. On peut aussi y observer des **milia**, micro-papules kératogènes blanches-jaunâtres le plus souvent retrouvées sur le nez, les joues et le front. Elles régressent spontanément.



Concernant la **peau**, on pourra aussi rechercher:

- Pétéchies et hématomes (signes d'un accouchement traumatique)
- Erythèmes toxiques (régressent spontanément)
- Taches de naissances
- Ictère (facilement jugulé par lumineothérapie ou disparition spontanée)
- Etc.

A noter que, en absence d'autres signes d'appel, les lésions cutanées nécessitent rarement une prise en charge dermatologique.

Oreilles

Celles-ci doivent pouvoir **revenir spontanément en place** après déformation manuelle. Ce ne sera pas le cas chez les prématurés où l'oreille restera dans la position déformée. Cette caractéristique est aussi retrouvée chez les enfants atteints de certaines maladies génétiques.

COU

L'examen du cou consistera en:

- Palpation des **SCM**
- Mobilité du cou et de la nuque (exclusion de torticollis congénital)
- Palpation des **clavicules** (symétrie, fracture)

THORAX

L'examen du thorax comprendra les examens **cardiaque** et **respiratoire** (cf. ci-dessous). A noter que la présence d'une hypertrophie mammaire est, chez les filles comme chez les garçons, normale et fréquente (causée par l'imprégnation par les oestrogènes maternels).

EXAMEN RESPIRATOIRE

Vérifier:

- **Symétrie thoracique**
- **FR** (N: environ 30/min)
- **Mouvements respiratoires**: **possible respiration diaphragmatique** à cet âge (i.e. thorax creusé et abdomen bombé durant l'inspiration)
- **Acrocyanose?** Peut-être normale à la naissance mais après: couleur N=**rose**
- **Détresse respiratoire?** (battements ailes du nez, tirage intercostal, tirage sus-claviculaire, etc.)

EXAMEN CARDIOVASCULAIRE

Celui-ci comprendra l'examen cardiaque en soi ainsi que la palpation de certains pouls. A **l'examen cardiaque**, donc, on auscultera:

- **4 foyers** (aortique, pulmonaire, mitral et tricuspide)
- N.b.: le foyer mitral est plutôt parasternal G

Enfin, on cherchera à palper et à comparer les **pouls**:

- Brachiaux
- Fémoraux
- Comparé pouls brachiaux et fémoraux (N=symétriques et synchrones)

Concernant le cordon ombilical, il faut TOUJOURS vérifier la **présence de trois vaisseaux** (2 artères et une veine). Une variation de la norme doit conduire à un US des reins.

EXAMEN ABDOMINAL

La paroi abdominale est normalement faible (surtout chez les prématurés). Ceci explique la présence courante, et sans valeur pathologique, de **diastase des grands droits** (=hernie de la ligne blanche) et/ou **d'hernie ombilicale**.

Il faudra aussi songer à vérifier la présence de:

- **Abdomen scaphoïde** (i.e. concave) suggérant une hernie diaphragmatique
- **Abdomen distendu** suggérant la présence d'un iléus méconial

Lors de la **palpation**:

- **Foie**: palpable jusqu'à 2cm du rebord costal
- **Rate**: palpation possible de sa pointe
- **Reins**: sentis durant la palpation profonde

EXAMEN UROGENITAL

Chez les **filles**:

- Grandes **lèvres** proéminentes...
- ... palpées à la recherche de testicule
- **Ecoulement** non purulent possible et N (le plus souvent blanchâtre ou rosé)
- **Clitoris**: vérifier sa taille (>1cm=clitoromégalie)

Chez les **garçons**:

- **Scrotum**: normalement grand
- **Pénis**: N>2 cm (investigation si plus petit)
- Prépuce: N étroit et adhérent

Concernant le **système urinaire**: 1ères urines dans les 12h pour la plupart (95% dans les 24h).

Dans la même région, on en profitera pour vérifier la présence et l'état de **l'anus**. Le **méconium** devrait passer dans les 1ères 24h. Au-delà, une investigation sera nécessaire.

EXAMEN MUSCULOSQUELETTIQUE

En temps normal, on observe spontanément des **mouvements symétriques des extrémités** (MS et MI). Une asymétrie peut indiquer soit une lésion osseuse, soit une lésion nerveuse.

On vérifiera aussi **doigts** et **orteils** à la recherche de syndactylie ou de polydactylie.

Concernant les pieds, il faudra exclure la présence de **pieds bots** en mobilisant ces derniers, une attitude en inversion non corrigible manuellement signant la présence de ces derniers.

Au niveau des hanches, on recherchera la présence d'une **luxation congénitale des hanches**. Celle-ci est réalisée par une manoeuvre en deux temps:

1. Test de **Barlow**: la jambe fléchie à 90° (genou) est poussée en AP et en légère adduction (hanche)
2. Test **d'Ortolani**: la hanche est ensuite remise en position par un mouvement simple d'abduction

MEMBRES SUPERIEURS et INFERIEURS

On vérifiera, ici :

- Symétrie
- Taille
- Position au repos
- Nombre de doigts et d'orteils (polydactylie vs. Syndactylie)
- Pieds : une position en inversion non réductible indique un pied bot
- Amplitude des mouvements

EXAMEN NEUROLOGIQUE

Celui-ci sera l'occasion de vérifier la présence des réflexes archaïques (disparaissent vers l'âge de ...) ainsi que le tonus des membres.

- **Inspection**
 - Posture (décubitus dorsal) : hanches, genoux et coudes normalement fléchis, en position dorsale (CAVE jambes de grenouilles)
 - **Extension passive d'un membre** : celui-ci revient normalement en flexion
 - Niveau d'alerte : testé avec une stimulation tactile au niveau de la joue qui devrait normalement le réveiller (ou, tout du moins, susciter une réaction de sa part)



- **Réflexe de Moro**

- Le NN couché est pris par les mains et légèrement relevé de la table puis relâché brusquement
- Ses bras décrivent alors un mouvement d'étreinte symétrique dans le but d'agripper la mère...
- ... un Moro complet étant obtenu si le bébé pleure



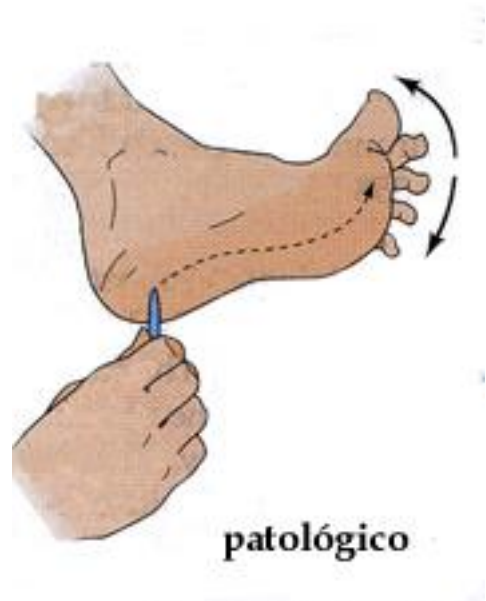
- **Réflex de Galant**

- Le NN pris à une main en position ventrale est chatouillé parallèlement à son rachis
- Le test est normal si une flexion latérale est déclenchée du même côté que les chatouilles



- **Autres réflexes archaïques**

- **Grasping** ou réflexe de préhension (plantaire et palmaire)
- Signe de **Babinski**
- Réflexe de **succion** (avec une sucette ou un doigt ganté)



- **Tonus musculaire**

- Supérieur : testé en ramenant les bras vers la ligne médiane (en adduction) qu'ils ne doivent pas dépasser (sinon, pathologique)
- Inférieur : testé en poussant la jambe genou fléchi du côté crânial, la flexion de la

- **Marche** : le NN présente des mouvements de marche, lorsqu'il est tenu debout et incliné vers l'avant, les pieds au contact de la table
- **Enjambement** : dans la même optique de la marche, le NN enjambe un obstacle, quand celui-ci lui est présenté (ex : bord de la table d'examen)

